CIRCULAR N° 0151

FECHA: Septiembre 4 de 2023

PARA: ALCALDÍAS, DIRECCIONES LOCALES DE SALUD, GERENTES INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD, EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS QUE OPERAN EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

DE: SECRETARÍA DE SALUD DE BOYACÁ - DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN – DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO

ASUNTO*: LINEAMIENTO PARA LA ACTIVACIÓN DE LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA POR RAZÓN DE SEXO Y GÉNERO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.*

La Secretaría de Salud de Boyacá de conformidad con las funciones asignadas mediante la Ley 715 de 2001, Artículo 43.4.1, Ley 1122 de 2007 y Ley 1438 de 2011, Decreto 780 del 2016, Decreto 1710 de 2020, Decreto 1231 de 2022 (departamental), Resolución 459 de 2012, Resolución 4568 de 2014, Resolución 276 de 2019, Resolución 051 de 2023, y Resolución 3280 de 2018 Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud, y en atención a los compromisos departamentales y nacionales contemplados para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, particularmente los relacionados con la salud y bienestar para todos, la equidad de género y la Política Nacional de Sexualidad Derechos Sexuales y Reproductivos, insta a los actores del sistemas general de seguridad social del departamento al cumplimiento de la ruta de atención integral en salud a víctimas de violencia por razón de sexo y genero de mujeres, niñas, niños, y adolescentes garantizando la atención integral a víctimas de violencia sexual y de género y su núcleo familiar.

Las violencias por razones de género, se ocasionan a partir del ejercicio de poder, violencia, coerción, intimidación, fundamentadas en la subvaloración de lo que socialmente se asigna como femenino desde los roles, estereotipos e imaginarios de género.

La atención integral a las víctimas de violencias de género, se entiende como todas aquellas acciones que la persona necesita para recuperar el control y la autonomía sobre su cuerpo, sus decisiones y sobre su proceso de recuperación, esto implica que la víctima sea atendida desde la integralidad de sus necesidades en función de su protección y recuperación y que se trascienda la mirada sectorial e institucional de la atención, para ello se deben identificar sus características particulares, las características del evento y del tipo de violencia, las necesidades inmediatas y mediatas de la víctima y su grupo familiar, así como la oferta institucional, que permite apoyar sin barreras ni cargas administrativas la recuperación, restitución de sus derechos y reparación de manera oportuna y suficiente.

En el marco de la atención integral a las víctimas de violencia razones de genero se ha establecido la triada de atención de los sectores de salud, protección y justicia; desde salud, para garantizar la intervención sobre las consecuencias en salud física y mental que puedan haber causado las violencias, desde la protección, para garantizar el restablecimiento de derechos y la no repetición de los eventos y desde Justicia para que el delito no quede impune, para cada caso, los sectores deben contar con acciones, medidas y protocolos que contribuyan al bienestar de la víctima y de su grupo familiar, a la recuperación integral, al ejercicio de sus derechos y a la reparación integral.

ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD

Esta ruta se adopta a partir de la Resolución 459 de 2012 Modelo y Protocolo de Atención Integral en salud para víctimas de violencia sexual siendo de obligatorio cumplimiento para los actores, tanto públicos como privados, que integran el Sistema General de Seguridad Social en Salud e incluye los servicios, procedimientos diagnósticos y terapéuticos, medicamentos e insumos aplicables para la atención de cada víctima en particular según Resolución 3100 de 2019 del MSPS o la norma que la modifique, derogue o sustituya (ver anexo). Cada institución de salud debe contar con un documento del proceso institucional que orienta la atención en salud de las víctimas de violencias sexuales y un

documento que dé cuenta de la conformación del equipo institucional, así como Programa de inducción, reinducción y plan de capacitación del talento humano asistencial y administrativo en atención a víctimas. Para la efectiva y eficaz activación de la ruta integral en la atención en salud, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Una víctima de violencia sexual deberá ser atendida siempre como una urgencia médica garantizando la confidencialidad y evitando la revictimización; independientemente del tiempo transcurrido desde el suceso, si la IPS no cuenta con servicio de urgencias habilitado debe realizar tramite de remisión y trasladar a la víctima a red de referencia.
- La atención en salud a víctimas de violencia sexual debe ser gratuita, no se deben interponer barreras de acceso como copagos, cuotas moderadoras u otros condicionantes (Sentencia T- 735 de 2017).
- En el caso que la persona víctima de violencia sexual sea víctima del conflicto armado deberá estar incluida en el Registro Único de Víctimas - RUV o en una orden o sentencia judicial y ser afiliada de manera inmediata al SGSSS.
- Para la atención integral de las personas con discapacidad, deberán determinarse y proveerse los apoyos, ajustes razonables y salvaguardias de acuerdo a los lineamientos de la Resolución 1904 de 2017).
- Si aún no han transcurrido más de 72 horas, en los casos donde hubo contacto sexual se proporcionará profilaxis para disminuir el riesgo de contagio de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y VIH, además de anticoncepción de emergencia para reducir el riesgo de embarazo.
- Tomar las pruebas diagnósticas necesarias para explorar el estado de salud de la víctima.
- Ofrecer asesoría para IVE (Interrupción voluntaria del embarazo) en el marco de la Resolución 051 de 2023 del MSPS, realizar las remisiones pertinentes a especialidades y programar los seguimientos que se requieran según el caso.
- Realizar la notificación rutinaria con periodicidad semanal a Sivigila de casos sospechosos de violencia de género e intrafamiliar, a través de la ficha de notificación código INS: 875 y notificación inmediata de todos los casos de víctimas de ataques con agentes químicos independientemente del sexo o edad de la víctima y de los casos de mutilación genital.
- Realizar la valoración integral en salud con el fin de identificar las afectaciones a la salud como consecuencia de las violencias, canalizar a la víctima a los servicios de salud y complementarios que requiera en el marco de las Rutas Integrales de Atención en Salud, independientemente del tiempo transcurrido desde del acto violento
- Activar la ruta de atención integral sectorial e interinstitucional a la víctima de violencia de género e intrafamiliar definida en el municipio.
- Denunciar los casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes e informar a las autoridades la ocurrencia de hechos punibles, si la persona afectada no lo ha realizado o sus condiciones de salud se lo impiden.
- Manejo de evidencia y cadena de custodia de los elementos materia de prueba recolectada durante el proceso de atención integral en salud.
- Toda persona migrante en el país, víctima de violencias sexuales debe ser atendida como urgencia.

ACTIVACION DE RUTAS: Proceso de atención intersectorial a las víctimas de violencia de género

Según el modelo y protocolo de atención integral de víctimas de violencia sexual, el sector salud es responsable de establecer la remisión a los sectores de justicia, protección y demás que requiera la persona víctima (Resolución 0459 de 2012)

Activación sector Justicia: ante un caso de violencia sexual, se debe informar a la autoridad competente, (Fiscalía, URI, Policía Nacional), esto puede hacerse de manera formal directamente en las instalaciones de la entidad o de manera informal a través de comunicación escrita (oficio remisorio, correo electrónico) o incluso verbal (como, por ejemplo, por medio de una llamada telefónica, si se conserva un soporte que pueda dar cuenta de su realización).

Activación Sector Protección: En los casos de violencia de género en especial violencia sexual el sector salud debe informar también a la entidad responsable del sector de protección en su municipio de

acuerdo con la ruta previamente definida, en tal caso, informará a la Comisaría de familia o ICBF, según corresponda.

Bajo ninguna circunstancia se dará de alta al niño, la niña o adolescente, hasta que se haya entregado el caso al sector encargado de la protección, sí en el momento de la atención en salud, la entidad encargada de la protección no puede acudir porque no se encuentra en su horario de atención, el sector salud procederá a hacer una hospitalización por protección. (Res. 3280 de 2018).

Otras competencias: Para los casos de explotación sexual y trata de personas se plantean los mismos protocolos de salud aplicados según el tipo de caso. Para los casos con víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado se hará la atención de urgencias y se garantizarán los procesos intersectoriales que, orientados a la seguridad de la víctima, quien puede presentar riesgos sobre su vida e integridad. En tal caso, se realizarán acciones con Personería o Unidad de víctimas del municipio y la activación del programa de protección a víctimas de la Fiscalía.

SEGUIMIENTO

Es competencia de la IPS que presta la atención en salud realizar un seguimiento del caso a los 15 días, así mismo, en articulación con la EPS se realizará un seguimiento del caso, cuando se cumplan un mes, tres, seis y doce meses después de ocurrida la primera atención. El sector salud debe además realizar los seguimientos periódicos para evaluar la salud física, mental y psicosocial de la víctima.

Las Secretarías de Salud y Direcciones Locales de Salud deben realizar las actividades de vigilancia y control para garantizar la adecuada atención a las víctimas de violencias sexuales de las entidades e instituciones que prestan los servicios de salud.

En los espacios de coordinación intersectorial se debe realizar el análisis de la situación de la problemática de violencias de género con énfasis en violencias sexuales, con enfoque de riesgos y determinantes sociales, con el fin de establecer cuáles son las acciones a realizar por los diferentes sectores y monitorear y evaluar la respuesta institucional.

La actividad se podrá realizar mediante: Análisis de la situación de las violencias de género y sexual, donde se identifiquen variables de tiempo, lugar y persona; factores de riesgo y protectores, determinantes sociales, como: estilos de vida, oferta institucional pública o privada, influencias comunitarias, soportes sociales, políticas, planes y programas y condiciones de vida. Esta información es la consolidación de los ejercicios de diagnóstico y caracterización que estén en las diferentes instituciones, planes de desarrollo, territoriales, institucionales, entre otros.

Cordialmente,

LYDA MARCELA PÉREZ RAMÍREZ
Secretaria de Salud Boyacá

NANCY JUDITH MUNÉVAR SEPÚLVEDA
Directora de Promoción y Prevención en Salud

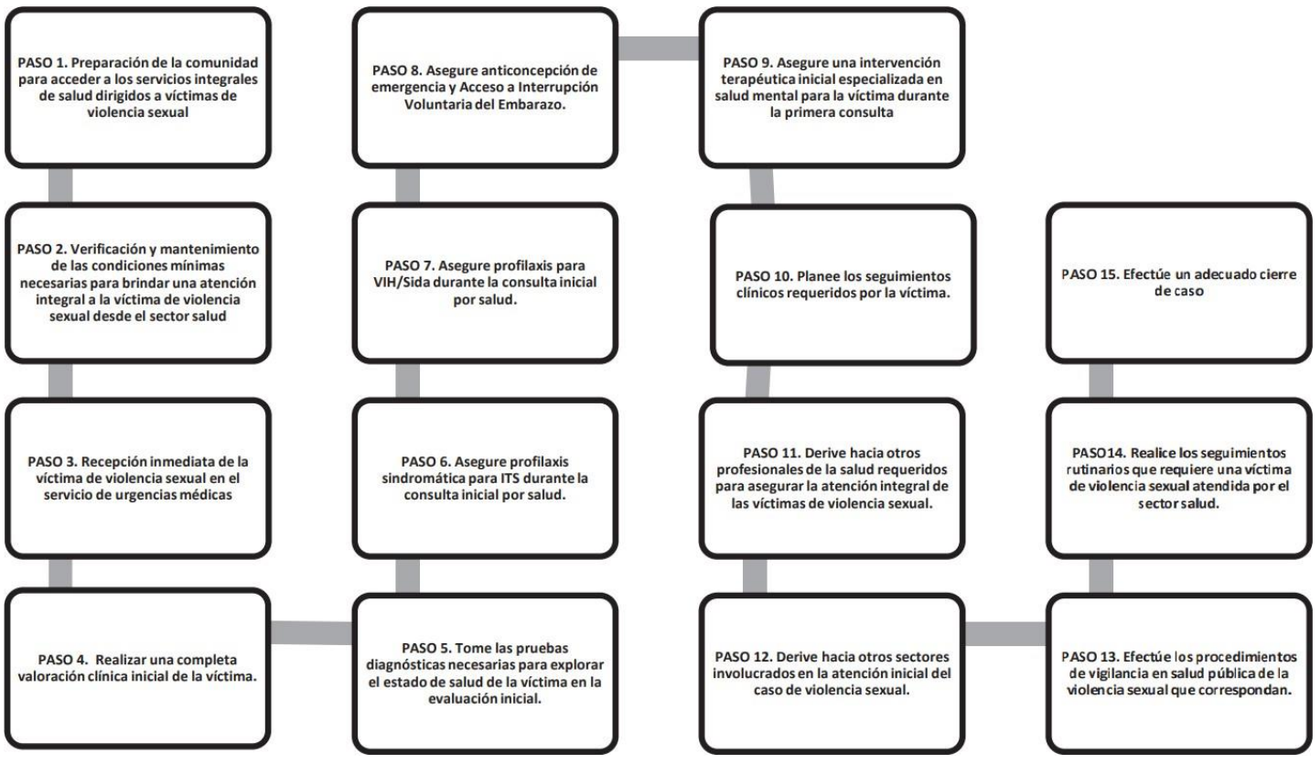
HENRY MAURICIO CORREDOR
Director de Prestación de Servicios de Salud

JHYRA JULIET PINZON PEÑA
Directora de Aseguramiento en Salud

Revisó: Clara Sonia Guerrero & Constanza Marcela García & Libia Rosmira Perilla- Profesionales Especializados Secretaría de Salud Boyacá

Proyectó: Claudia Sofía Daza & Otilia Cepeda Pérez - Profesionales Especializados de Apoyo DPYPS –Dimensión Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos

PASOS FUNDAMENTALES EN LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL



Fuente: Anexo Técnico Resolución 459 de 2012.MINSALUD